

المثانة المفرطة النشاط

دليل المريض الشامل

تمارين المثانة المتقدمة
تعديلات نمط الحياة العلمية
خيارات العلاج الشاملة
لاسترجاع السيطرة الكاملة

د. جورج شاكر

أخصائي المسالك البولية

NHS Urology Specialist

ما هي المثانة المفرطة النشاط؟

المثانة المفرطة النشاط هي حالة شائعة تصيب ملايين الأشخاص حول العالم. تتميز بالشعور المفاجئ والملح بالحاجة للتبول يصعب تأجيله، وقد يصاحبه تسرب لا إرادي للبول. هذه الحالة ليست جزءاً طبيعياً من التقدم في العمر ويمكن علاجها بفعالية.

تصيب هذه الحالة حوالي ١٥٪ من البالغين، وتزداد شيوعاً مع التقدم في السن. تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة والنشاط الاجتماعي والنفسي، لكن كثير من المرضى لا يطلبون المساعدة الطبية بسبب الإحراج.

• الأعراض الرئيسية

- الإلحاح البولي — شعور مفاجئ وقوي بالحاجة للتبول يصعب تأجيله وقد يسبب قلقاً شديداً
- تكرار التبول — أكثر من ٨ مرات في النهار وهو أكثر من المعدل الطبيعي
- التبول الليلي — الاستيقاظ مرتين أو أكثر ليلاً للتبول مما يؤثر على جودة النوم
- سلس الإلحاح — تسرب البول قبل الوصول للحمام بسبب شدة الإلحاح المفاجئ

• الأسباب والعوامل المساهمة

١ ضعف عضلات قاع الحوض

بسبب الحمل والولادة أو التقدم في العمر أو السمنة مما يقلل دعم المثانة

٢ فرط نشاط العضلة الدافعة

تقلصات لا إرادية في عضلة المثانة حتى عندما لا تكون ممتلئة

٣ مشاكل عصبية

مثل السكتة الدماغية أو التصلب المتعدد أو مرض باركنسون أو إصابات الحبل الشوكي

٤ عوامل نمط الحياة

الكافيين والكحول والتدخين والسمنة وقلة النشاط البدني

تمارين المثانة المتقدمة

تدريب المثانة هو الخط الأول والأهم في العلاج. الهدف هو إعادة تعليم المثانة تخزين كميات أكبر من البول وتقليل الإلحاح. يحتاج البرنامج ٦ إلى ١٢ أسبوعا لتحقيق نتائج ملموسة.

• تمارين كيجل لتقوية قاع الحوض

- حدد العضلات الصحيحة — تخيل أنك تحاول إيقاف تدفق البول أو منع خروج الغازات
- اقبض هذه العضلات لمدة ٥ ثوان ثم ارخها لمدة ٥ ثوان — كرر ١٠ مرات
- تدرج تدريجيا لتصل إلى ١٠ ثوان قبض و ١٠ ثوان إرخاء
- كرر التمارين ٣ مرات يوميا — صباحا وظهرا ومساء
- لا تقبض عضلات البطن أو الفخذين — ركز فقط على عضلات قاع الحوض
- يمكن أداء هذه التمارين في أي مكان — أثناء الجلوس أو القيادة أو العمل

• برنامج تدريب المثانة

الأسبوع ١-٢

ابدأ بالذهاب للحمام كل ساعة حتى لو لم تشعر بالحاجة — سجل أوقات التبول في دفتر يومي

الأسبوع ٣-٤

زد الفترة بين كل زيارة بمقدار ١٥ دقيقة — عند الشعور بالإلحاح توقف وخذ نفسا عميقا واقبض عضلات كيجل

الأسبوع ٥-٨

استمر في زيادة الفترة تدريجيا حتى تصل إلى ٣ إلى ٤ ساعات بين كل تبول

الأسبوع ٩-١٢

حافظ على الجدول وراقب التحسن — معظم المرضى يلاحظون تحسنا بنسبة ٥٠٪ أو أكثر

نصيحة مهمة

عند الشعور بالإلحاح مفاجئ: توقف — خذ ٣ أنفاس عميقة — اقبض عضلات كيجل ٥ مرات سريعة عادة يزول الإلحاح خلال ٣٠ إلى ٦٠ ثانية ويمكنك بعدها المشي بهدوء للحمام

تعديلات نمط الحياة العلمية

تغيير بعض العادات اليومية يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في السيطرة على أعراض المثانة المفرطة النشاط. هذه التعديلات مبنية على أبحاث علمية موثقة.

● إدارة السوائل

- اشرب ١.٥ إلى ٢ لتر يومياً — تقليل السوائل بشكل مبالغ فيه يزيد تركيز البول ويهيئ المثانة
- وزع الشرب على مدار اليوم — لا تشرب كميات كبيرة دفعة واحدة
- قلل السوائل مساءً — أوقف الشرب قبل النوم بساعتين لتقليل التبول الليلي
- تجنب الكافيين — القهوة والشاي والمشروبات الغازية تهيج المثانة بشكل مباشر

● أطعمة صديقة للمثانة

- الماء العادي والأعشاب الخالية من الكافيين مثل البابونج والنعناع
- الكمثرى والموز والتفاح — فواكه غير حمضية ولطيفة على المثانة
- الخبز الكامل والأرز البني والشوفان — ألياف تمنع الإمساك الذي يضغط على المثانة
- البروتينات الخفيفة مثل الدجاج والسّمك والبيض
- الخضروات غير الحمضية مثل الجزر والبروكلي والفاصوليا الخضراء

● أطعمة ومشروبات يجب تجنبها

- القهوة والشاي الأسود والمشروبات الغازية — مدرات للبول وتهيج المثانة
- الحمضيات والطماطم — البرتقال والليمون والجريب فروت تزيد حموضة البول
- الأطعمة الحارة والتوابل القوية — تهيج بطانة المثانة
- الشوكولاتة — تحتوي على الكافيين والثيوبورومين المهيجين للمثانة
- المحليات الصناعية — أظهرت الأبحاث أنها تهيج المثانة عند بعض المرضى

● عادات يومية مهمة

- حافظ على وزن صحي — كل ٥ كغ زيادة في الوزن تزيد الضغط على المثانة بنسبة ملحوظة
- عالج الإمساك — الإمساك المزمن يضغط على المثانة ويزيد الأعراض
- ألق عن التدخين — السعال المزمن يضعف عضلات قاع الحوض
- مارس الرياضة بانتظام — المشي واليوغا والسباحة ممتازة لصحة الحوض

خيارات العلاج الشاملة

إذا لم تكف تعديلات نمط الحياة وتمارين المثانة، هناك خيارات علاجية متعددة فعالة. العلاج يبدأ بالأبسط ويتدرج حسب استجابة المريض.

• العلاج الدوائي

١ مضادات الكولين

مثل الأوكسيبوتينين والسوليفيناسين والتولثيرودين. تعمل على إرخاء عضلة المثانة وتقليل التقلصات اللاإرادية. قد تسبب جفاف الفم والإمساك.

٢ ميرابيجرون

دواء حديث يعمل بآلية مختلفة. يرخي عضلة المثانة ويزيد سعتها. آثاره الجانبية أقل من مضادات الكولين. مناسب لكبار السن.

٣ كريمات الإستروجين الموضعية

للنساء بعد انقطاع الطمث. تحسن صحة أنسجة المهبل والإحليل وتقلل أعراض المثانة.

• العلاجات المتقدمة

٤ حقن البوتوكس في المثانة

يحقن في عضلة المثانة عبر المنظار. يرخي العضلة لمدة ٦ إلى ٩ أشهر. فعال جدا للحالات التي لم تستجب للأدوية. يمكن تكراره.

٥ تحفيز العصب العجزي

جهاز صغير يزرع تحت الجلد يرسل نبضات كهربائية خفيفة للأعصاب المتحكمة في المثانة. نتائج ممتازة طويلة المدى.

٦ تحفيز العصب الطنبوبي

علاج غير جراحي — إبرة رفيعة بالقرب من الكاقل ترسل نبضات للأعصاب. جلسة أسبوعية لمدة ١٢ أسبوعا.

متى تراجع الطبيب فورا؟

دم في البول — ألم شديد عند التبول — حمى مع أعراض بولية
تغير مفاجئ في عادات التبول — عدم القدرة على التبول نهائيا

عن الكاتب

د. جورج شاكر

أخصائي المسالك البولية

NHS Urology Specialist — United Kingdom

الزمالة المصرية في جراحة المسالك البولية
عضو الكلية الملكية للجراحين — بريطانيا
• الزمالة الأوروبية في المسالك البولية
٨ سنوات خبرة في طب المسالك البولية
٥ سنوات خبرة في الخدمة الصحية الوطنية البريطانية

تابعني على إنستغرام وتيك توك
@dr.george.shaker

هذا الدليل للتقيف الصحي فقط ولا يغني عن استشارة الطبيب المختص
جميع الحقوق محفوظة ٢٠٢٦